

Ejercicio y neuroplasticidad en enfermedad de Parkinson: de la evidencia a la sesión clínica

Síntesis clínica · 2026-09-14

Resumen ejecutivo

El ejercicio es una intervención modificadora de síntomas en Parkinson, con potencial impacto en plasticidad sináptica, marcha y equilibrio. La dosis, la especificidad de la tarea y la adherencia definen el beneficio clínico.

Esta síntesis clínica de Metabolic Fitness Academy traduce evidencia contemporánea en fisiología del ejercicio aplicada a criterios prácticos para médicos, kinesiólogos y fisiólogos clínicos en Latinoamérica.

Bases de plasticidad y ejercicio

El entrenamiento aeróbico y las tareas cognitivo-motoras pueden favorecer BDNF y circuitos relacionados con control motor. Aunque no curan la enfermedad, mejoran velocidad de marcha, longitud de paso, equilibrio y síntomas no motores como sueño y ánimo cuando se prescriben de forma consistente.

Componentes de una sesión efectiva

Incluya aeróbico (caminata, cicloergómetro), fuerza de MMI y tronco, entrenamiento de marcha con variaciones (giros, dual-task) y equilibrio dinámico. La intensidad moderada-vigorosa, tolerada y supervisada, suele asociarse a mejores resultados que el ejercicio muy suave aislado.

Individualización por estadio

En estadios tempranos, enfatice prevención de descondicionamiento y dual-task. En estadios avanzados, priorice seguridad, transferencias, prevención de caídas y cuidadores. Ajuste al horario de medicación dopaminérgica para aprovechar ventanas de mejor movilidad ON.

Implicaciones clínicas

Diseñe sesiones multimodalidad, sincronice con medicación cuando sea útil y documente marcha, equilibrio y caídas. Supervise progresión y fatiga.

Referencias y marcos de evidencia

- Movement Disorder Society reviews on exercise in Parkinson's disease.
- Clinical guidelines for physiotherapy in Parkinson's.